



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : صباح سيد فرج عبد العظيم
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الجيزة
رقم البطاقة : 29306172101403 رقم التليفون : 01155213593
العمر (تاريخ الميلاد) : 17-06-1993 المهنة : ربه منزل
العنوان : بشتيل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الاورام

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي تراستوزوماب تحت الجلد و بيرتوزوماب (فيسجو) [14117]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صباح سيد فرح عبد العظيم National ID: 29306172101403	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي (Phesgo (Subcutaneous trastuzumab and pertuzumab

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقق الشخصية

صباح
سيد فرج عبد العظيم
٣ من الرحمة الإسلامية بشتيل
مركز اوسيم - الجيزة

١٩٩٣/٠١/١٧ ٢٩٣٠٦١٧٢١٠١٤٠٣

JB5718881

٢٠٢١/٠١/١٧ ٢٩٣٠٦١٧٢١٠١٤٠٣

ربة منزل
أنثى

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١٠/٠٥

١

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول
الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-2-2

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ة) صباح سيد فرج عبدالعظيم بطاقة رقم 29306172101403
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2026-2-2

الموظف المختص

احمد ياسر

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 1895075



الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Name: صباح سيد فرج عبدالعظيم			
MR. : 9411			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحية طبية وبعد,,			
إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient was evaluated for a newly diagnosed breast cancer and a neoadjuvant chemotherapy (NACT) regimen of TCHP was planned; the patient declined targeted therapy, and the administrative correspondence was addressed accordingly. On initial examination a left lower quadrant breast mass measuring approximately 8 × 5 cm was identified. The intended regimen for cycle 1 (C1) was weekly taxol combined with carboplatin AUC 5, with PHESGO to be administered during week 1 of C1 (taxol/carbo AUC 5). Clinical pharmacy documentation recorded the patient's weight at 66 kg, height 158 cm, and surface area 1.7 m². The prescribed dose was taxol 130 mg and carboplatin AUC 5; PHESGO was unavailable at that time. Imaging demonstrated a premalignant left breast lesion classified as CT3 N2. Surgical clips were placed, and pathology revealed IDC grade 3, estrogen receptor 0/8, progesterone receptor 0/8, HER2 2+, Ki-67 90%. Physical examination noted a left-sided axillary lymph node measuring 3 × 4 cm and another node 2 × 2 cm. The patient received week 5 (W5) taxol 135 mg and carboplatin AUC 2 as neoadjuvant therapy, along with a loading dose of PHESGO 1200/600 mg after approval; week 6 (W6) taxol and carboplatin were administered with a 7-day interval, achieving a response of 68 %. Daycare pharmacy note for week 6 recorded taxol 130 mg, carboplatin AUC 2, and one prophylactic dose of Neupogen. For week 7 the patient received taxol 130 mg, carboplatin AUC 2, and a cycle 1 loading dose of PHESGO. Multidisciplinary team discussion in April 2026 recommended placement of a port catheter and initiation of NACT TCHP for six weeks: week 8 taxol/carbo, followed by hydra-sec in weeks 9 and 10, with cycle 2 PHESGO to be incorporated. Daycare pharmacy note for week 8 confirmed administration of taxol 130 mg and carboplatin AUC 2. The patient developed fever and pharyngitis during cycle 2 PHESGO, prompting a one-week postponement of chemotherapy. In week 9 taxol and carboplatin AUC 2 were planned; laboratory results from the prior week were reviewed, and a contaminated urine culture prompted collection of a repeat midstream specimen and initiation of empirical antibiotics. During week 10 the patient experienced hypersensitivity to carboplatin administered in the previous cycle; pre-medication with solucotide was ordered before the next cycle, and plans were made for week 11 taxol/carbo AUC 2, with supportive treatment and continuation of PHESGO in cycle 3 after			
تحريرا في ,			
التاريخ :		21-09-2026	
الوقت :			
الطبيب المعالج :		dina makram	
يعتمد ,			

laboratory clearance.

For week 11 the patient received taxol 130 mg, carboplatin AUC 2, and cycle 3 PHESGO; laboratory values showed hemoglobin 9 g/dL, platelets $121 \times 10^9/L$, total lymphocyte count $4.2 \times 10^9/L$, absolute neutrophil count $1.9 \times 10^9/L$, and serum creatinine 1.14 mg/dL. The patient has now completed week 11 of the taxol/carbo regimen and cycle 3 of PHESGO.

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصريةالمنشأة المصرية
للصحة

04/15/2026

MDT FORM

Name:	Sabah عبد فرج Abdelazeem	MRN:	9411
Age:	33 Y	ID:	29306172101403
Menopausal Sta	REGULAR	Phone:	01155213593
NRS SCORE:		Marital Status:	Married
BMI:		Family History:	-VE
CO Morbidity:	NAD	Reason Of MDT:	NEW

Clinical Data:

BX:	IDC G111						
ER:	0/8	PR:	0/8	HER2:	3	KI67:	90%

R

L

Sonomammography:

It LOQ mass 8x4 cm 3-6 oclock 5 cm from nipple and abutting skin
(two LOQ masses with intraductal extension inbetween)
+ pathological 1,2 ,infradavicular Ins cT3N3

Mets Workup:

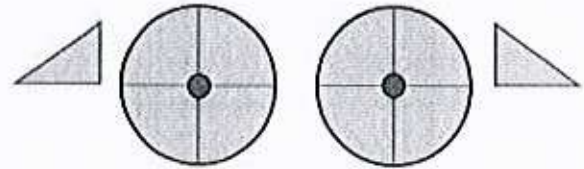
free

History:Recommendations:

for NACT AFTER CLIPPING

MDT Outcome & Plan

For CESM + Possibility of Bracketing of LOQ 2 masses, then
Port cath and Start NACT TCHP *6 and surgery acc to CESM



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ ندي حسن	د/ عبد السلام شادي				

Patient Name : الأستاذ / صباح سيد فرج
Patient No. : 29306172101403
Path No. : 327/26
Sex : Female
Age : 32 Y
Referring Doc :

Request No. : 13004842
Request Date : 03/02/2026
Verification Date : 12/02/2026
Financial Category : جريئة - مبادرة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast LOQ mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 03/02/2026, at 12:30 pm.

Gross Examination:

- Multiple fragmented grey white tissue cores, the longest is 1.5 cm. Totally submitted.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).
- * Ductal carcinoma in situ: Absent.
- * Microcalcification: Present.
- * Angioinvasion: Absent.
- * Perineural invasion: Absent.

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):

- ER: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 90%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 3.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 24/02/2026 10:31:59

Page 1 of 3

Printing By : marwa mohamed youss

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذ / صباح سيد فرج

Patient No. : 29306172101403

Path No. : 327/26

Sex : Female

Age : 32 Y

Referring Doc :

Request No. : 13004842

Request Date : 03/02/2026

Verification Date : 12/02/2026

Financial Category : جوستاف روسي - مياذره

Department : Out Patient

Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

IPT:

- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 90%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low) membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 24/02/2026 10:31:59

Page 2 of 3

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / صباح سيد فرج :
Patient No. : 29306172101403
Path No. : 327/26
Sex : Female
Age : 32 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13004842
Request Date : 03/02/2026
Verification Date : 12/02/2026
Financial Category : جوسف روسي - مبادره :
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 24/02/2026 10:31:59

Page 3 of 3

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Name : Sabah Sayed Farag

Date ;28-4-2026

Contrast Enhanced Mammogram study (CEDM):

Technique: non-iodinated contrast material (Omnipaque 300mg%) was injected manually through an antecubital vein cannula.

Indication : left LOQ, pathologically proven IDC. For asses:ment before chemotherapy.

Findings:

Low energy images:

- Heterogeneously dense bilateral breast parenchyma (ACR C).
- Left breast LOQ deeply seated hyper dense ill defined mass lesion.
- No right breast suspicious mass lesions or microcalcifications.

High energy images:

- Moderate background parenchymal enhancement (BPE).
- Left breast LOQ irregular mass lesion showing heterogeneously enhancement. It measures about (7.5 x 4.3 cm) along axial dimensions measured in the CC view. It is seen about (4.3 cm from the nipple . The lesion is seen just abutting the pectoral muscle.
On complementary US , multiple variable sized hypo echoic mass lesions are seen at left breast extending from 3-6 o'clock with unhealthy intervening parenchyma . it is seen about 2.5 mm from the overlying skin.
- Multiple enlarged left axillary lymph nodes are seen (level 1 , II & infraclavicular)
- No right breast suspicious enhancing mass lesions or areas of non mass enhancement.

Patient ID: 92902	Patient Name English: Sabah Said Farag
Age: ٣٢ سنة ٧ أشهر	2026/02/01 12:12:34 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 32 years old female patient with left breast lump.

Left breast:

- Heterogeneously dense breast parenchyma (ACR density C).
- The Left breast LOQ focal asymmetry, with dense masses showing internal suspicious microcalcifications, measuring about 8x4cm.
- Complementary US showed multiple heterogenous hypoechoic irregular inter-communicating masses with intraductal extension in between. Occupying the whole LOQ (3 – 6 o'clock), Located at seen about 5 cm from the nipple and abutting the overlying skin.
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple (about 5 in number) pathological level 1 axillary LNs showing globular configuration and lost hilum, the largest measures about 1.5x1.2 cm.
- Two pathological level 2 (sub-pectoral) axillary LNs, the largest measures 2x0.7 cm.
- Pathological infraclavicular LN is noted measuring about 1.5x0.6 cm.

Right breast:

- Heterogeneously dense breast parenchyma (ACR density C).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): Left LOQ malignant process as described with ipsilateral pathological level 1, 2 and infraclavicular axillary LNS as described for histopathological confirmation.
- Right breast (BIRADS 1): normal study.

*Much obliged,
Dr. Alaa Ahmed, MSC
Dr. Ghada Khaled, MSC*

Name : Sabah Said Farag Abdelazim

Date : 19-06-2026 06:45

Branch : Dokki

Medical No. : 397365

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins.Company : تعاقد مستشفيات

Whole-Body Bone Scintigraphy Report

- **Indication:** Left breast carcinoma in a 59-year-old female patient; staging/baseline evaluation.
- **Symptoms:** Intermittent bone aches.

Technique

- Anterior and posterior whole-body planar imaging.

Findings

Axial Skeleton:

- Normal, symmetric tracer distribution throughout the calvarium, cervical, thoracic, and lumbar spine. Alignment is preserved.
- Homogeneous uptake without focal costal lesions or fracture lines.
- Symmetric tracer localization in the sacroiliac joints and iliac crests; no focal pelvic lesions.

Appendicular Skeleton:

- Symmetric physiological uptake in the long bones and major joints bilaterally. No focal osteoblastic cortical abnormalities.

Soft Tissue & Excretion:

- Prompt, symmetric renal clearance. Normal urinary bladder activity. No pathologically altered extraosseous tracer localization.

Conclusion

- No scintigraphic evidence of osteoblastic metastatic skeletal disease.

Dr. Alaa Nagi,
MD Nuclear Medicine

٩٤١١

Patient's Name: sabah sayed farag abd elazim
Date: 2026-03-26
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

I- CHEST:

- Known case of left breast cancer showed right breast heterogeneously enhancing mass lesion measuring 52 x 31 mm with heterogenous enhancement and overlying skin thickening.
- left axillary enlarged lymph nodes, the largest measures 20 mm.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

- ❖ Known case of left breast cancer with left axillary lymph nodes.
- ❖ No hepatic or pulmonary metastatic lesions.

Dr.Assem Ahmed



Patient's Name: sabah sayed farag abd elazim
Date: 2026-03-26
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Dr.Assem Ahmed